PROJETO PILOTO DOCTOR PRESCREVE

Plataforma Digital de Acesso a Prescrições Médicas para Pacientes Crônicos

Responsável Técnico: Dr. Max Vinicius Ferreira Matos
CRM-SP: 163032
Período: Março a Agosto de 2026 (6 meses)
Versão: 1.0 – Projeto Piloto

---

1. JUSTIFICATIVA E CONTEXTO

1.1 Problema Identificado

Pacientes portadores de doenças crônicas (Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Dislipidemia e outras condições que exigem tratamento contínuo) enfrentam barreiras significativas para manter acesso regular às suas prescrições medicamentosas[1]:

- Filas prolongadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com espera superior a 30 dias para consulta de rotina
- Falta de disponibilidade de médicos para renovação de receitas simples
- Deslocamento desnecessário a serviços de urgência/emergência apenas para obtenção de receita médica
- Interrupção do tratamento por impossibilidade de acesso à prescrição, levando a descompensação clínica
- Sobrecarga dos serviços de pronto-socorro com demandas não urgentes

1.2 Solução Proposta

O **Doctor Prescreve** é uma plataforma médica digital regulamentada que oferece acesso facilitado e seguro a prescrições médicas para pacientes crônicos, por meio de telemedicina, com foco em:

- Avaliação médica remota estruturada
- Prontuário eletrônico integrado
- Prescrição digital válida conforme CFM e ANVISA
- Entrega multicanal (WhatsApp, e-mail, SMS)
- Continuidade do cuidado e redução de idas desnecessárias ao pronto-socorro

1.3 Objetivo Geral

Garantir acesso rápido, seguro e regulamentado a prescrições médicas para pacientes crônicos estáveis, reduzindo a sobrecarga dos serviços de urgência e promovendo continuidade terapêutica.

1.4 Objetivos Específicos

1. Implementar plataforma de telemedicina aderente à Resolução CFM nº 2.314/2022
2. Estruturar sistema de prontuário eletrônico conforme CFM nº 1.821/2007 e LGPD
3. Emitir prescrições digitais válidas segundo Resolução CFM nº 2.218/2018 e RDC ANVISA nº 586/2021
4. Atender prioritariamente pacientes com HAS, DM, DLP e outras condições crônicas
5. Estabelecer fluxo de triagem e critérios de elegibilidade claros
6. Avaliar impacto na redução de idas ao pronto-socorro para obtenção de receitas

---

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REGULATÓRIA

2.1 Telemedicina

Resolução CFM nº 2.314/2022 – Define e regulamenta a telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias digitais[2].

Artigos aplicáveis ao Doctor Prescreve:

- Art. 3º – A telemedicina é permitida em todo o território nacional, em caráter privado, público ou suplementar
- Art. 4º – É obrigatório ao médico: I) estar regularmente inscrito no CRM; II) possuir registro de qualificação de especialidade quando couber
- Art. 6º – O atendimento por telemedicina deve garantir a integridade, segurança e sigilo das informações
- Art. 9º – É obrigatória a obtenção e registro do consentimento livre e esclarecido do paciente
- Art. 12º – A teleconsulta deve ser registrada em prontuário clínico, com data, hora, tecnologia utilizada e dados clínicos
- Art. 15º – O médico pode solicitar exames e emitir receitas, atestados e laudos a distância

2.2 Prontuário Eletrônico

Resolução CFM nº 1.821/2007 – Normas técnicas para digitalização e uso de sistemas informatizados para guarda e manuseio de prontuários[3].

Requisitos obrigatórios:

- Identificação do paciente e do médico responsável
- Data e hora de cada atendimento
- Registro de anamnese, exame físico (quando aplicável), hipóteses diagnósticas, conduta e prescrição
- Mecanismos de segurança, backup e auditoria
- Preservação do sigilo médico (LGPD – Lei nº 13.709/2018)

2.3 Prescrição Digital

Resolução CFM nº 2.218/2018 – Estabelece normas para uso de prescrição eletrônica de medicamentos[4].

RDC ANVISA nº 586/2021 – Regulamenta a escrituração de receitas de medicamentos controlados (receituário amarelo e azul) por meio eletrônico[5].

Requisitos para validade jurídica:

- Assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou plataforma CFM de prescrição eletrônica
- Identificação completa do médico (nome, CRM, especialidade)
- Identificação do paciente (nome, documento)
- Data de emissão
- Medicamento, posologia, quantidade e orientações de uso
- Validade da prescrição conforme legislação vigente

Observação: Para medicamentos de receita controlada (amarela e azul), é obrigatório o uso do sistema de prescrição eletrônica homologado pela ANVISA, com transmissão ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC)[5].

2.4 Proteção de Dados

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018 – Regula tratamento de dados pessoais sensíveis, incluindo dados de saúde[6].

Obrigações aplicáveis:

- Consentimento explícito do paciente para coleta e tratamento de dados
- Finalidade específica e legítima (atendimento médico)
- Medidas de segurança técnicas e administrativas
- Nomeação de encarregado de proteção de dados (DPO)
- Garantia de direitos do titular (acesso, correção, exclusão)
- Armazenamento em servidores localizados no Brasil ou com garantias adequadas

---

3. ESTRUTURA OPERACIONAL DO PROJETO PILOTO

3.1 Público-Alvo Prioritário

Critérios de inclusão:

- Pacientes adultos ($\geq$ 18 anos)
- Diagnóstico estabelecido de condição crônica estável:
  - Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
  - Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)
  - Dislipidemia (DLP)
  - Hipotireoidismo
  - Outras condições crônicas sob avaliação médica
- Em uso regular de medicação há pelo menos 3 meses
- Impossibilidade de acesso à renovação de receita por via convencional (UBS sem agenda, deslocamento dificultado)
- Condição clínica estável (sem sintomas de descompensação)

Critérios de exclusão:

- Sintomas agudos ou sinais de descompensação (dor torácica, dispneia, alteração de consciência, hipoglicemia grave, crise hipertensiva)
- Primeira prescrição do medicamento (necessita avaliação presencial)
- Mudança recente de esquema terapêutico (menos de 30 dias)
- Solicitação de medicamentos controlados de uso restrito sem documentação prévia
- Pacientes sem documentação médica anterior

3.2 Fluxo Operacional

Figure 1: Fluxo de atendimento Doctor Prescreve – Fase Piloto

Etapa 1 – Captação e triagem automatizada

1. Paciente acessa plataforma via WhatsApp Business ou site
2. Sistema automatizado realiza triagem inicial:
   - Identificação do paciente (nome, CPF, telefone)

    - Doença crônica e medicamentos em uso
    - Data da última prescrição e última consulta
    - Presença de sintomas de alarme
3. Sistema classifica elegibilidade:
    - **Verde**: renovação simples (encaminha para médico)
    - **Amarelo**: necessita avaliação detalhada (agenda teleconsulta)
    - **Vermelho**: sintomas de urgência (orienta buscar PS)

Etapa 2 – Análise médica e prontuário eletrônico

1. Médico acessa prontuário eletrônico com dados do paciente
2. Revisão de:
    - Histórico de prescrições anteriores
    - Documentos anexados (receitas antigas, exames, laudos)
    - Dados da triagem
3. Decisão médica:
    - **Aprovação direta**: prescrição emitida (casos verdes estáveis)
    - **Teleconsulta necessária**: agendamento de videochamada
    - **Encaminhamento presencial**: orientação para UBS ou emergência

Etapa 3 – Teleconsulta (quando indicada)

1. Realizada por videochamada segura (plataforma própria ou homologada)
2. Anamnese direcionada e orientações terapêuticas
3. Registro completo em prontuário eletrônico
4. Prescrição emitida ao final da consulta

Etapa 4 – Emissão de prescrição digital

1. Prescrição gerada com assinatura digital (certificado ICP-Brasil ou sistema CFM)
2. Envio simultâneo via:
    - WhatsApp (PDF)
    - E-mail (PDF anexado)
    - SMS (link de acesso)
3. Armazenamento no prontuário eletrônico do paciente
4. Registro no sistema de auditoria

Etapa 5 – Acompanhamento e follow-up

1. Mensagem automatizada em 7 dias: "Como você está? Conseguiu o medicamento?"
2. Identificação de pacientes que não retiraram medicação
3. Orientação para retorno médico ou ajuste de conduta

3.3 Tecnologia e Infraestrutura

Sistemas obrigatórios:

Componente	Especificação
WhatsApp Business API	Automação de triagem e entrega de receitas
Prontuário Eletrônico	Sistema próprio ou integrado (ex.: Zoho CRM + Healthtech)
Plataforma de Telemedicina	Videochamada segura, LGPD-compliant
Assinatura Digital	Certificado ICP-Brasil A1 ou A3 / Sistema CFM
Armazenamento	Servidores no Brasil, criptografia, backup diário
Sistema de Envio	Integração WhatsApp + E-mail + SMS

Table 1: Infraestrutura tecnológica mínima

Segurança e conformidade:

- Criptografia de ponta a ponta para dados sensíveis
- Política de privacidade e termos de uso apresentados ao paciente
- Consentimento registrado eletronicamente (check obrigatório)
- Log de auditoria de todos os acessos ao prontuário
- Backup automático diário
- DPO designado (pode ser terceirizado inicialmente)

3.4 Equipe Mínima – Fase Piloto

Função	Responsabilidade
Médico Responsável Técnico	Dr. Max Vinicius Ferreira Matos – CRM-SP 163032
Médico(s) Assistente(s)	Atendimento, prescrições, teleconsultas (pode iniciar apenas com RT)
Gestor de Operações	Monitoramento de fluxo, suporte técnico, triagem secundária
Desenvolvedor/Suporte TI	Manutenção da plataforma, integrações, segurança
Encarregado de Dados (DPO)	Conformidade LGPD, auditorias (pode ser terceirizado)

Table 2: Equipe inicial

---

4. ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO

4.1 Parcerias com Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Objetivo: Atingir diretamente o público-alvo (pacientes crônicos cadastrados nas UBS) por meio de parceria com ACS e equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).

Ações:

1. Elaboração de material informativo institucional (panfletos, folders, cartazes)
2. Apresentação do projeto para coordenações de UBS e equipes de ESF
3. Treinamento breve para ACS sobre o funcionamento da plataforma
4. Distribuição de panfletos em visitas domiciliares e na própria UBS
5. QR Code nos materiais para acesso direto via WhatsApp

Conteúdo do panfleto:

- "Você é portador de pressão alta, diabetes ou colesterol alto?"
- "Está sem sua receita e não consegue agendar na UBS?"
- "O Doctor Prescreve pode te ajudar!"
- Explicação simples do serviço
- WhatsApp de contato
- QR Code de acesso

4.2 Comunicação Digital

- Perfil no Instagram com conteúdo educativo sobre doenças crônicas e uso correto de medicamentos
- Postagens semanais sobre HAS, DM, DLP (sintomas, tratamento, adesão medicamentosa)
- Depoimentos de pacientes (com autorização e anonimização quando necessário)
- Link na bio para acesso direto ao WhatsApp

4.3 Canais de Acesso

- WhatsApp Business: número fixo divulgado amplamente
- Site institucional: doctorprescreve.com.br (futuro)
- Link direto: wa.me/55XXXxxxxxxxx
- QR Code em materiais impressos

---

5. CRITÉRIOS DE SUCESSO E INDICADORES

5.1 Indicadores Quantitativos (6 meses)

Indicador	**Meta Piloto**
Pacientes cadastrados	150
Prescrições emitidas	200
Teleconsultas realizadas	80
Taxa de renovação simples (sem teleconsulta)	60%
Tempo médio de resposta (triagem → prescrição)	$<$ 24h
Satisfação do paciente (NPS)	$>$ 70

Table 3: Metas de desempenho – fase piloto

5.2 Indicadores Qualitativos

- Redução subjetiva de idas ao pronto-socorro para "pegar receita" (questionário pós-atendimento)
- Continuidade do tratamento medicamentoso (paciente conseguiu manter medicação em uso)
- Satisfação com o atendimento e facilidade de uso da plataforma
- Percepção de segurança e confiança no serviço

5.3 Indicadores de Conformidade

- 100% dos atendimentos com registro em prontuário eletrônico
- 100% das prescrições com assinatura digital válida
- 100% dos pacientes com termo de consentimento registrado
- Zero não conformidades em auditorias internas de LGPD
- Zero reclamações formais ao CRM ou CREMESP

---

6. RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Impacto	Mitigação
Percepção de "fábrica de receitas" sem avaliação médica	Questionamento ético e regulatório	Critérios de elegibilidade rígidos, registro em prontuário, recusa quando inadequado
Emissão de prescrição para paciente descompensado	Agravamento clínico, responsabilidade médica	Triagem estruturada, sinais de alarme bloqueiam emissão automática, teleconsulta obrigatória em casos duvidosos
Vazamento de dados de saúde (LGPD)	Multas, perda de confiança	Criptografia, auditoria, DPO, política de segurança da informação
Falta de aderência de ACS/UBS	Baixa captação de pacientes	Apresentação institucional, benefício mútuo (reduz sobrecarga do PS), material de fácil distribuição
Assinatura digital inválida	Receita recusada em farmácias	Uso de certificado ICP-Brasil ou plataforma oficial CFM, testes antes do lançamento

Table 4: Matriz de riscos e mitigações

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase	Prazo
Desenvolvimento da plataforma (prontuário + automação)	Mês 1
Obtenção de certificado digital ICP-Brasil	Mês 1
Elaboração de materiais de divulgação (panfletos, QR Code)	Mês 1
Apresentação a coordenações de UBS e equipes ESF	Mês 2
Início da divulgação via ACS e redes sociais	Mês 2
Início dos atendimentos (soft launch – 10 pacientes/semana)	Mês 2
Expansão gradual (30–50 pacientes/mês)	Meses 3–4
Avaliação intermediária e ajustes	Mês 4
Consolidação e coleta de indicadores finais	Meses 5–6
Relatório final e decisão de expansão	Fim do Mês 6

Table 5: Cronograma – 6 meses

8. ORÇAMENTO ESTIMADO (FASE PILOTO – 6 MESES)

Item	Valor (R$)
Desenvolvimento/customização de plataforma	8.000
Certificado digital ICP-Brasil A3 (3 anos)	400
Hospedagem e infraestrutura (6 meses)	1.200
WhatsApp Business API (6 meses)	600
Materiais gráficos (panfletos, folders)	1.000
Marketing digital básico (anúncios, conteúdo)	2.000
Consultoria jurídica/LGPD (pontual)	2.500
Reserva operacional	2.300
Total estimado	**18.000**

Table 6: Orçamento fase piloto

Observação: Valores estimados para estrutura mínima. Pode variar conforme fornecedores e escopo.

---

9. ASPECTOS ÉTICOS E COMPROMISSOS

- O Doctor Prescreve se compromete a operar estritamente dentro das normas do Conselho Federal de Medicina, CREMESP, ANVISA e legislação vigente
- Todo atendimento será realizado com registro em prontuário, avaliação médica individual e critérios clínicos rigorosos
- Não haverá emissão de prescrições sem análise médica prévia
- Pacientes em situação de urgência serão orientados a buscar atendimento presencial imediato
- A plataforma não substitui o acompanhamento regular em serviços de saúde, apenas facilita o acesso pontual a prescrições quando necessário
- Todos os dados de saúde serão tratados com máximo sigilo, segurança e respeito aos direitos do paciente

---

10. CONCLUSÃO

O **Projeto Piloto Doctor Prescreve** representa uma solução inovadora, viável e regulamentada para um problema concreto do sistema de saúde brasileiro: a dificuldade de acesso a prescrições médicas por pacientes crônicos estáveis.

Ao integrar telemedicina, automação, prontuário eletrônico e prescrição digital válida, a plataforma oferece uma via segura e conveniente para continuidade terapêutica, reduzindo a sobrecarga dos serviços de urgência e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

A fase piloto permitirá testar a operação, validar a aceitação do público-alvo, ajustar fluxos e garantir plena conformidade legal antes de eventual expansão.

REFERÊNCIAS

[1] Ministério da Saúde. (2024). *Política Nacional de Atenção Básica*. Brasília: MS.

[2] Conselho Federal de Medicina. (2022). Resolução CFM nº 2.314/2022 – Define e regulamenta a telemedicina. *Diário Oficial da União*, seção 1, p. 227. https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2022/2314_2022.pdf

[3] Conselho Federal de Medicina. (2007). Resolução CFM nº 1.821/2007 – Normas técnicas para digitalização e uso de sistemas informatizados para guarda e manuseio de prontuários. https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2007/1821

[4] Conselho Federal de Medicina. (2018). Resolução CFM nº 2.218/2018 – Normas para uso de prescrição eletrônica de medicamentos. https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2218

[5] Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2021). Resolução RDC nº 586/2021 – Regulamenta a escrituração de receitas de medicamentos controlados por meio eletrônico. *Diário Oficial da União*, seção 1. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-586-de-26-de-agosto-de-2021

[6] Brasil. (2018). Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm